

소 속, 성 명 위원회심사실 ◎부 (v) 대리

제 목 사전심사 항목 모니터링 및 환류 활성화 최초 실행

내 용

1. 업무개요

위원회심사실은 「국민건강보험법 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제2항 및 제3항, 「사전심사의 절차 등에 관한 세부사항」(심평원 공고 제2024-25호 ‘24.2.1.시행)에 따라 고위험·고비용 의료서비스를 치료하기 전 요양기관에서 요양급여 적용 여부를 신청하여 결정해주는 사전심사 업무를 수행하고 있다.

2. 추진배경

사전심사항목은 '92년 조혈모세포이식을 시작으로 사전심사 항목 확대에 중점을 두었으나, 최근 혁신기술이나 고가의 혁신 신약의 개발이 활성화가 됨에 따라 사전승인 도입 확대가 예상되어, 그 간 사전심사로 노하우가 쌓인 항목은 사후심사로 전환하고, 새로운 신규 항목에 대해서는 신속하게 도입 할 기반 마련이 필요하였다.

3. 해결 및 개선점

사전심사 항목별로 승인율, 불승인 사유, 전환시 심사 일치율(심사위원간, 심평원·병원간), 급여기준개선 필요 여부, 사후심사 병행 여부 등 특징적 사항을 분석하여 전환 대상인 5개 항목을 발굴하였다. 항목별로 사전심사분과위원회 및 임상학회와 전문가 자문회의, 관련 협회 및 요양기관 간담회 등 의료현장 의견수렴을 통해 사후심사 전환 방안을 수립하였다. 항목별로 급여기준 개선이 필요하거나, 심사지침이 필요한 항목에 대해서는 기준명확화를 시행하였으며, 사전심사 노하우를 심사 부서에 교육 및 매뉴얼도 제작·배포하여 심사의 일관성을 유지시켰다. 또한 사후심사

전환으로 사전심사제도에 있어 탄력적 운영이 가능하여 1인당 단안 기준 약 3.3억 원에 달하는 고가의 유전적 망막위축질환 치료제를 신속하게 도입시켜 5명의 영구적 실명을 예방하였다.

4. 업무성과

사전승인제도 도입 이후 32년 만에 최초로 사전심사 5개 항목을 사후심사로 전환할 수 있었다. 이에 따라, ①사전심사 도입 → ②근거기반 승인여부 수행 → ③자료축적·모니터링 → ④사후심사 전환의 사전심사 환류체계가 완성되었다.

[표 1] 환류 달성 항목(사후심사 전환 5항목, 신규도입 1항목)

연번	항목명	해당 질환	가격	도입시기	전환시기
1	스트렌식주	소아기에 발현한 저인산 효소증	연간 3억천만원	'20. 6월	'24. 4월
2	솔리리스주 (PNH)	발작성 야간혈색소뇨증	연간 2억8천만원 (신규/지속투여)	'12.10월	'24. 4월
3	울토미리스주 (PNH)	발작성 야간혈색소뇨증	연간 4억 2천만원(신규) 연간 3억 7천만원(지속)	'21. 6월	'24. 4월
4	ICD (심율동전환제세동기)	부정맥 등	2천 4백만원 (행위+치료재료)	'16.12월	'25. 2월
5	CRT (심박기거치술)	부정맥이 동반한 심부전 환자 등	2천 4백만원 (행위+치료재료)	'16.12월	'25. 2월
6	렉스터나주	유전적 망막치료제	3억 3천만원(한쪽 눈)	'24.2월	-